12. 설사

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이현석

2025년 시험 24번 · 출제자 이현석

1. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

정답 ④

담낭절제술 뒤에 생긴 만성 수양성 설사로, 염증 소견(대변 백혈구, CRP)이 없고 혈변 · 복통도 없으므로 담즙산 설사(bile acid diarrhea)다. 담낭이 없으면 담즙산이 계속 장으로 흘러 대장에서 수분 · 전해질 분비를 자극한다. 담즙산 결합수지인 콜레스티라민이 치료제다. 리팍시민은 소장세균과증식, 코티코스테로이드는 염증성장질환에 쓴다.

2. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① 0.9% 식염수
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트리악손 정주

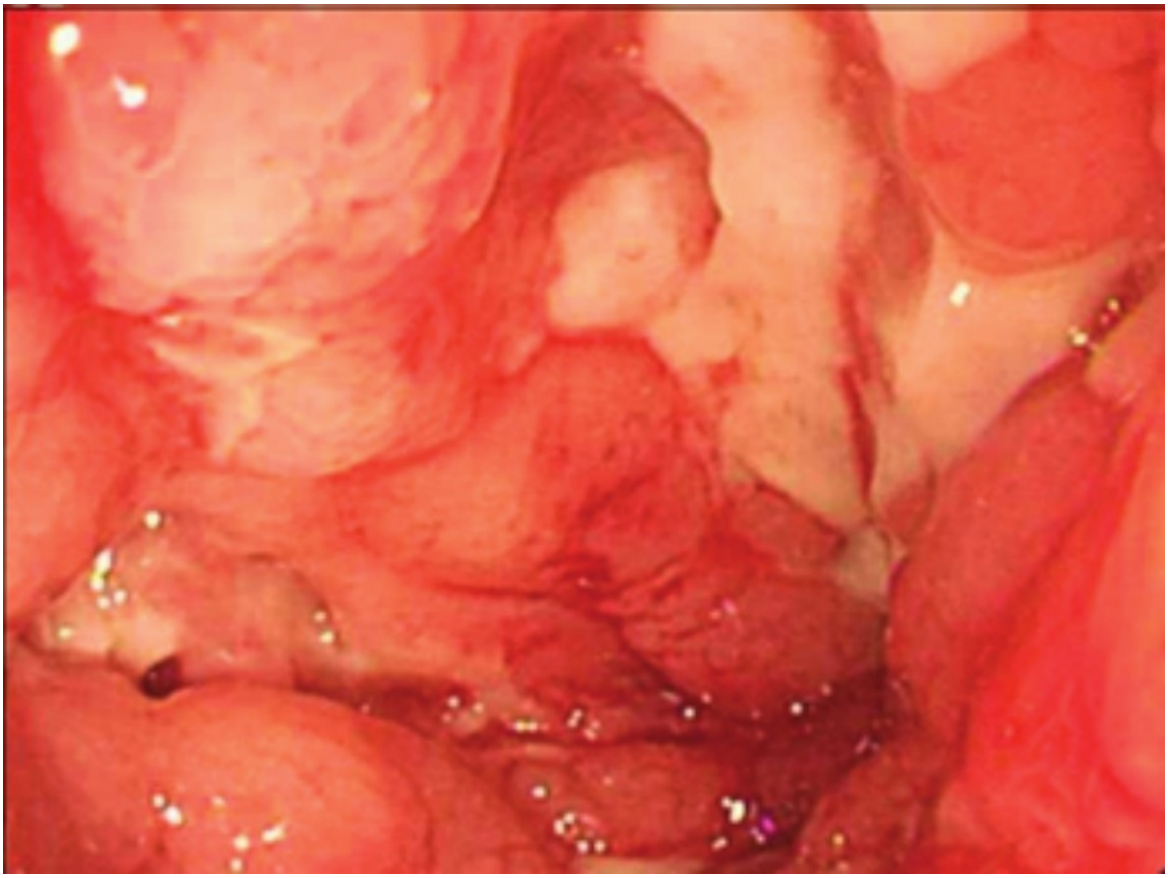
정답 ①

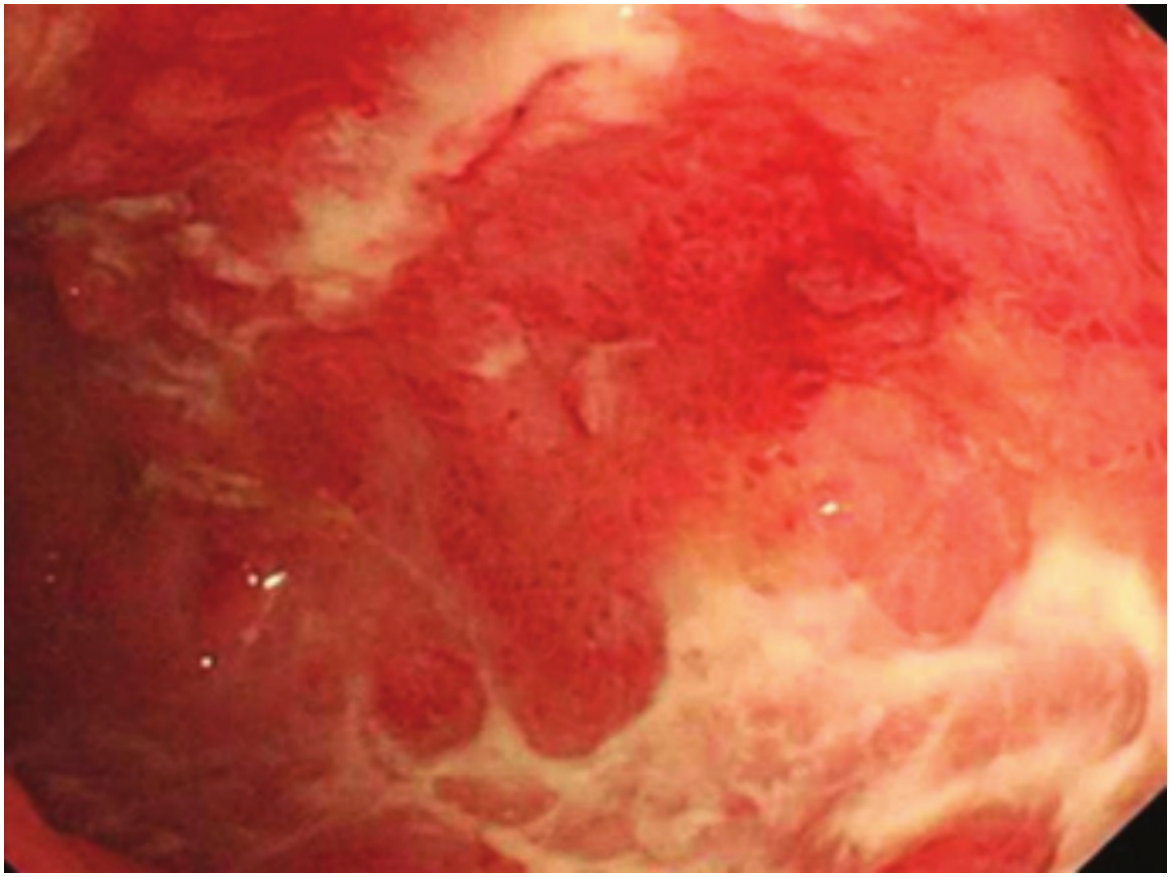
점심에 샐러드를 먹고 몇 시간 뒤 심한 구역과 수양성 설사가 시작된 급성 감염성(식중독) 설사다. 피부 긴장도 감소, 마른 혀, BUN/크레아티닌 상승(신전성 급성 신손상)이 있어 탈수가 핵심 문제이므로, 0.9% 생리식염수로 수액을 보충하는 것이 치료다. 발열이 미미하고 혈변 · 심한 염증 소견이 없어 대부분 저절로 좋아지므로 항생제는 필요 없다. 반코마이신 · 메트로니다졸은 C. difficile, 간시클로버는 CMV 장염 치료제다.

3. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

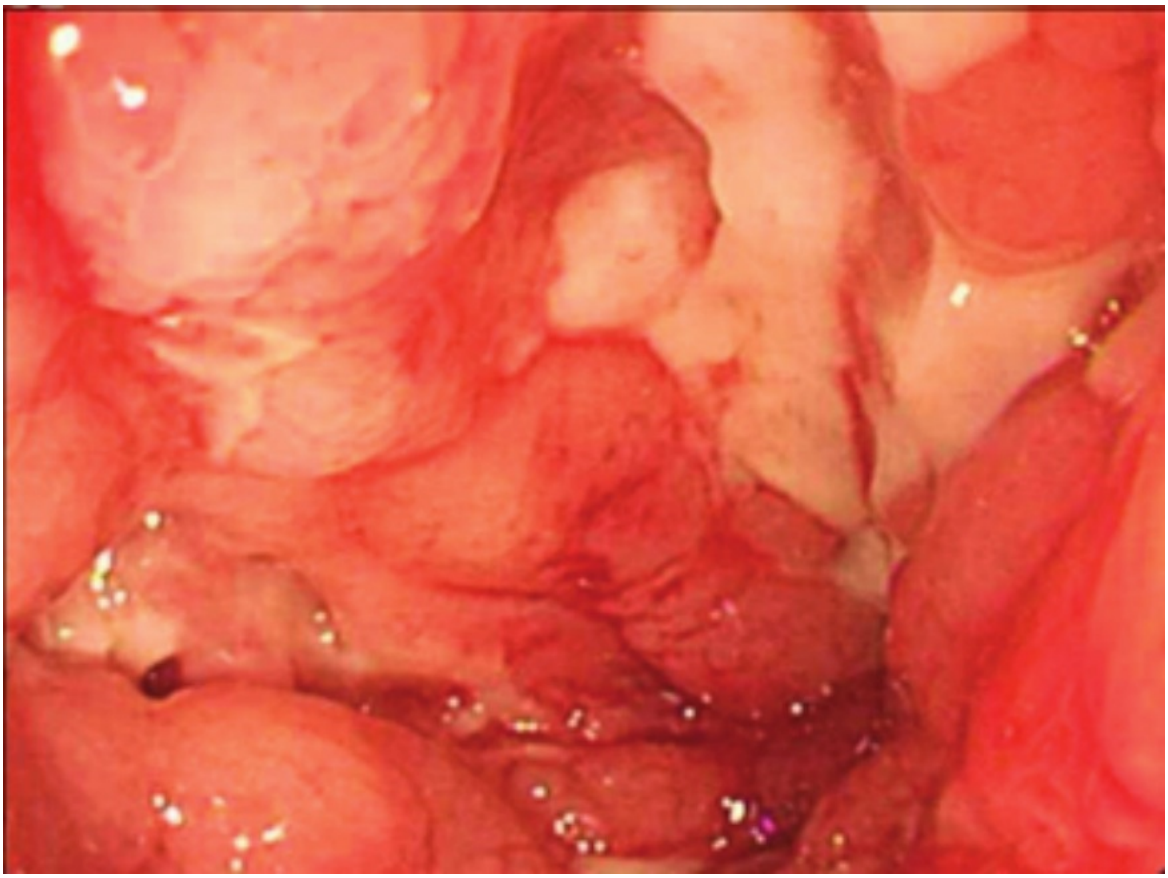
2024년

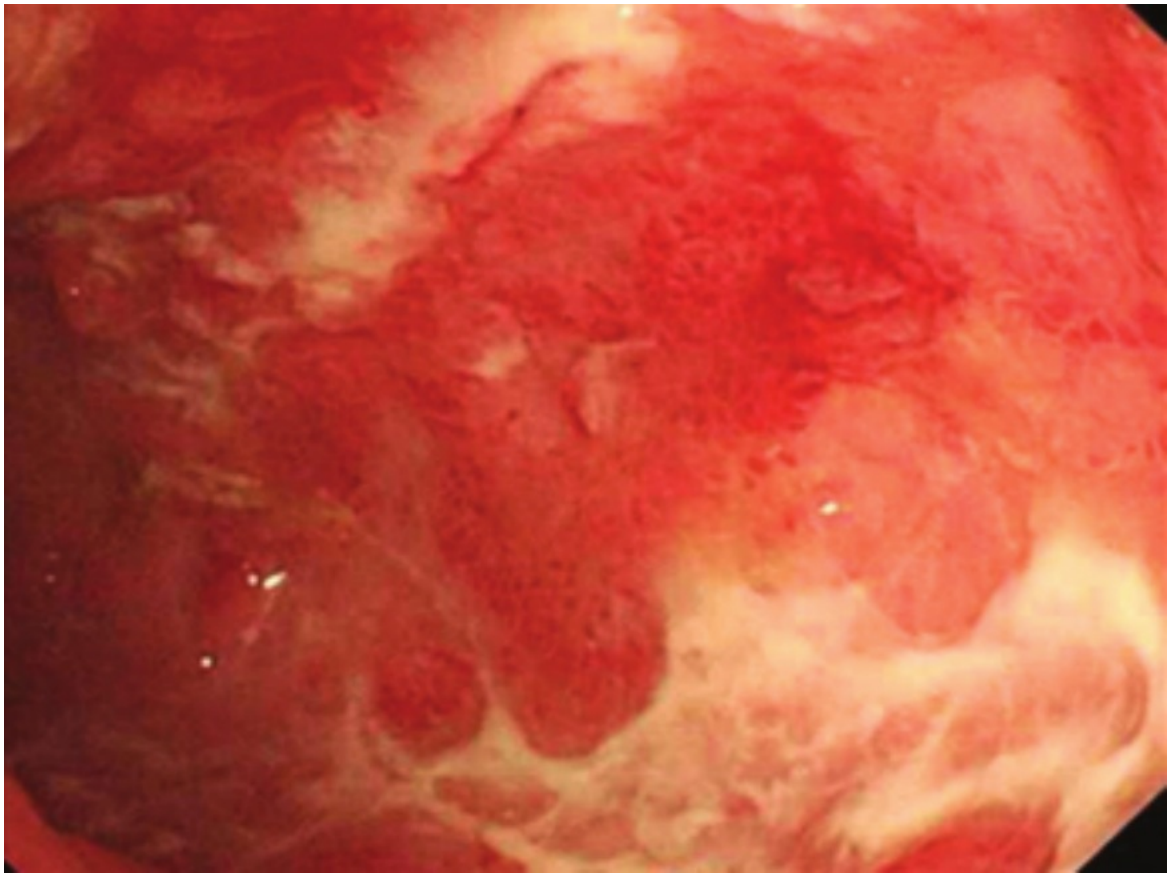
2024년 시험 16번 · 출제자 이현석

4. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

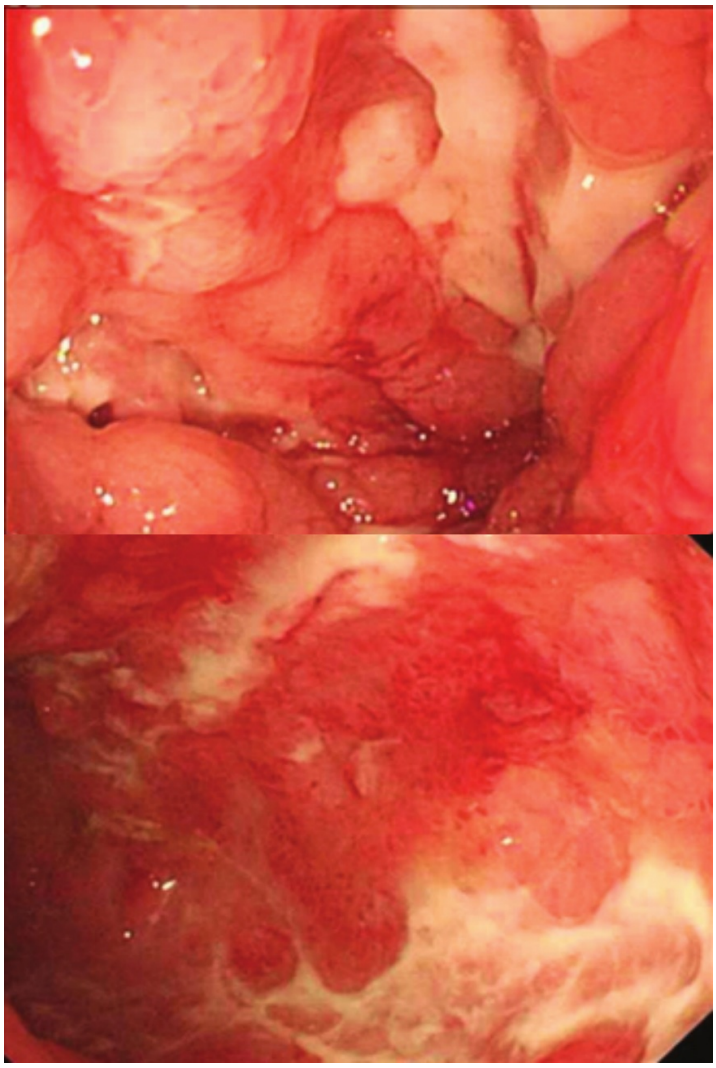
> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

2023년 시험 22번

5. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성



① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

정답 ①

젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

2023년 시험 56번

6. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① **0.9% 식염수**
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트라이악손 정주

정답 ①

점심에 샐러드를 먹고 몇 시간 뒤 심한 구역과 수양성 설사가 시작된 급성 감염성(식중독) 설사다. 피부 긴장도 감소, 마른 혀, BUN/크레아티닌 상승(신전성 급성 신손상)이 있어 탈수가 핵심 문제이므로 0.9% 생리식염수로 수액을 보충한다. 발열이 미미하고 혈변이 없어 항생제는 필요 없다. 반코마이신 · 메트로니다졸은 C. difficile, 간시클로버는 CMV 장염, 세프트리악손은 침습성 세균 감염에 쓴다.

2023년 시험 60번

7. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

정답 ④

담낭절제술 뒤에 생긴 만성 수양성 설사로, 염증 소견(대변 백혈구, CRP)이 없고 혈변 · 복통도 없으므로 담즙산 설사(bile acid diarrhea)다. 담낭이 없으면 담즙산이 계속 장으로 흘러 대장에서 수분 · 전해질 분비를 자극한다. 담즙산 결합수지인 콜레스티라민이 치료제다. 리팍시민은 소장세균과증식, 코티코스테로이드는 염증성장질환에 쓴다.

2022년

2022년 시험 2번

8. 35세 남자 환자가 내원 2년 전부터 시작된 설사로 내원하였다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 청진에서 장음이 증가되었고 타진에서 공명음은 들리지 않는다. 배는 부드러웠으며 압통 및 반발압통은 관찰되지 않았다. 환자 금식시에는 설사가 멈추는 양상을 보였다. 이와 같은 설사의 원인이 될 수 있는 것은?

① bowel resection
② osmotic laxatives
③ bile acid diarrhea
④ Addison's disease
⑤ carcinoid tumor

정답 ②

금식하면 멈추는 설사는 흡수되지 않는 물질이 장 안으로 물을 끌어들이는 삼투성 설사이며, 삼투성 하제(마그네슘, 락툴로오스, PEG 등)가 대표적인 원인이다(그 밖에 유당불내성, 소르비톨 등). 담즙산 설사, 장 절제 후 설사, 카르시노이드 종양, 애디슨병은 금식해도 지속되는 분비성 설사의 원인이다.

9. 78세 남자 환자가 1주일간 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 환자는 최근 폐렴으로 요양병원에 입원 중이었으며, 입원 중 항생제를 사용하였다고 한다. 설사는 물처럼 나오면서 하루 4-5회 있었으며, 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 적절한 검사는 ?

CBC WBC 12600/㎕ Hb 11.9 g/dL Hct 44% Plt 524K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 7.0/3.5 g/dL AST/ALT 14/10 IU/L

ALP 76 U/L TB/DB 1.1/0.8 mg/dL

BUN/Cr 32.2/1.5 mg/dL Na/K 132/2.8 mmoL/L

ESR 32 mm/hr CRP 8.3 mg/dL

① Stool microbiology

② Abdominal CT

③ Endoscopy

④ Capsule endoscopy

⑤ Rapid urease test

정답 ①

요양병원 입원 중 항생제를 쓴 고령 환자의 수양성 설사, 발열, 하복부 압통, 백혈구 증가는 Clostridioides difficile 감염을 가장 먼저 의심한다. 다음 검사는 대변으로 C. difficile 독소 · 유전자(PCR) 검사 등 대변 미생물 검사다. 복부 CT는 중증 · 합병증(독성 거대결장 등)이 의심될 때, 내시경(위막 확인)은 진단이 애매할 때 추가하며, 신속 요소분해효소검사는 헬리코박터 검사다.

10. 62세 여자 환자가 내원 3일전부터 발생한 복통 및 설사를 주소로 내원하였다. 환자 내원 당일 복통이 심해지면서 혈변을 200 cc 정도 보았다고 한다. 혈액 검사 소견 및 대장내시경 사진이다. 진단은?

CBC WBC 9700/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 434K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 6.1/3.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 135/3.4 mmoL/L

ESR 22 mm/hr CRP 9.1 mg/dL

① 궤양성대장염
② 크론병
③ 대장암
④ **허혈성대장염**
⑤ 결핵성대장염

정답 ④

고령에서 갑자기 생긴 복통 뒤 24시간 안에 선혈변이 나오는 것이 허혈성 대장염의 전형적인 경과다. 대장내시경에서 비장만곡부 · 하행 · 구불결장 같은 혈류 경계 부위에 분절성의 부종 · 출혈 · 궤양이 보인다. 궤양성대장염 · 크론병은 만성 경과의 젊은 환자, 대장암은 서서히 생기는 출혈과 배변 습관 변화, 결핵성 대장염은 회맹부 궤양이 특징이다.

2021년

2021년 시험 4번

11. 71세 남자가 5일 전 시작된 발열과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 있었고 복통이 동반되었다. 내원 2주 전 다리 골절로 수술을 받았다. 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 10/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 검사 결과는 다음과 같으며 S-결장 내시경 사진(그림)이다.

혈액검사 결과

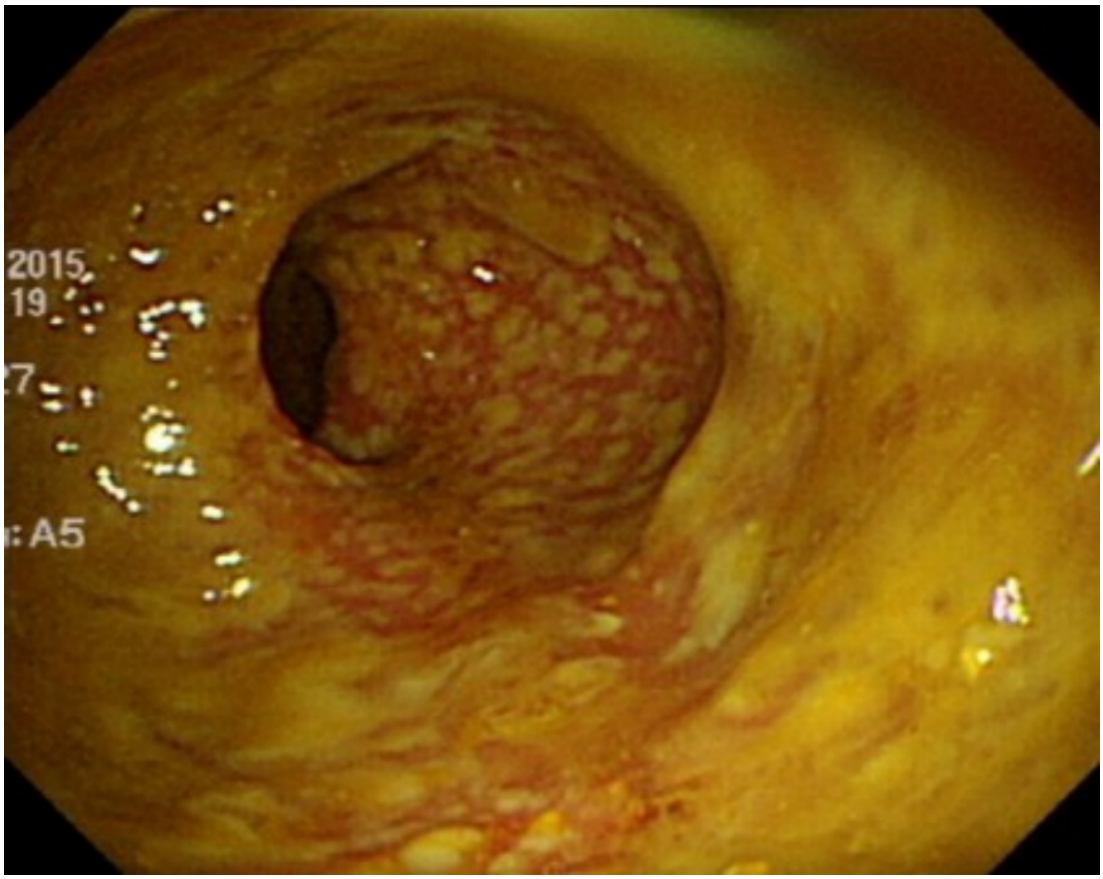
백혈구 20,500/㎕, 혈색소 11.6 g/dL 혈소판 224K/㎕

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 2.8g/dL

아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26U/L

혈액요소질소/크레아티닌 50.2/2.5 mg/dL

C-반응단백질 55 mg/L (참고치 < 10)



① 위막성결장염

② 크론병

③ 장결핵

④ 만성췌장염

⑤ 곁주머니염

정답 ①

수술 후 항생제를 쓴 고령 환자에서 발열, 수양성 설사, 하복부 압통, 백혈구 크게 증가(20,500), 저알부민혈증, 급성 신손상이 있고, S상결장 내시경에서 노란 판 모양의 위막이 보이면 C. difficile에 의한 위막성 대장염이다. 백혈구 15,000 이상이나 크레아티닌 1.5 이상이면 중증으로 분류하며, 경구 반코마이신 · 피닥소마이신으로 치료한다(원본의 '혈압 10/70'은 원본 그대로 둠).

2021년 시험 35번

12. 25세 남자가 8개월 전부터 무른 변을 본다며 병원에 왔다. 복통을 동반하였고, 배변 후 통증이 호전되었다. 1주일에 4일 정도 하루 수회의 무른 변을 보았다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부진찰에서 장음은 다소 증가되어 있고, 압통과 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다

① 곁주머니염
② **과민대장증후군**
③ 대장암
④ 궤양결장염
⑤ 혈관이형성증

정답 ②

8개월 동안 반복되는 복통이 배변하면 좋아지고 배변 횟수 · 대변 모양이 변하며, 체중감소 · 혈변 · 빈혈 · 발열 같은 경고 증상이 없는 젊은 남성이므로 과민대장증후군(Rome 기준)이다. 대장암 · 궤양결장염 · 혈관이형성증은 혈변 · 빈혈 같은 경고 소견을, 곁주머니염은 발열과 국소 압통을 보인다(원본에 '검사 결과'의 내용이 빠져 있음).

13. 60세 남자 환자가 3개월 이상 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 복통은 심하지 않았으나, 하루 3회 정도 설사가 있었다. 환자 과거력 상 결핵성 늑막염으로 20년 전 치료한 병력이 있었으며, 아랫배에 경한 압통이 있고, 반동압통은 없었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 혈액 검사는 다음과 같으며 대장내시경 사진 상 상행 대장에 다수의 궤양이 관찰 되었다. 가장 의심할 수 있는 질환은?

백혈구 98,500/mm³, 혈색소 11.9 g/dL

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 3.2 g/dL

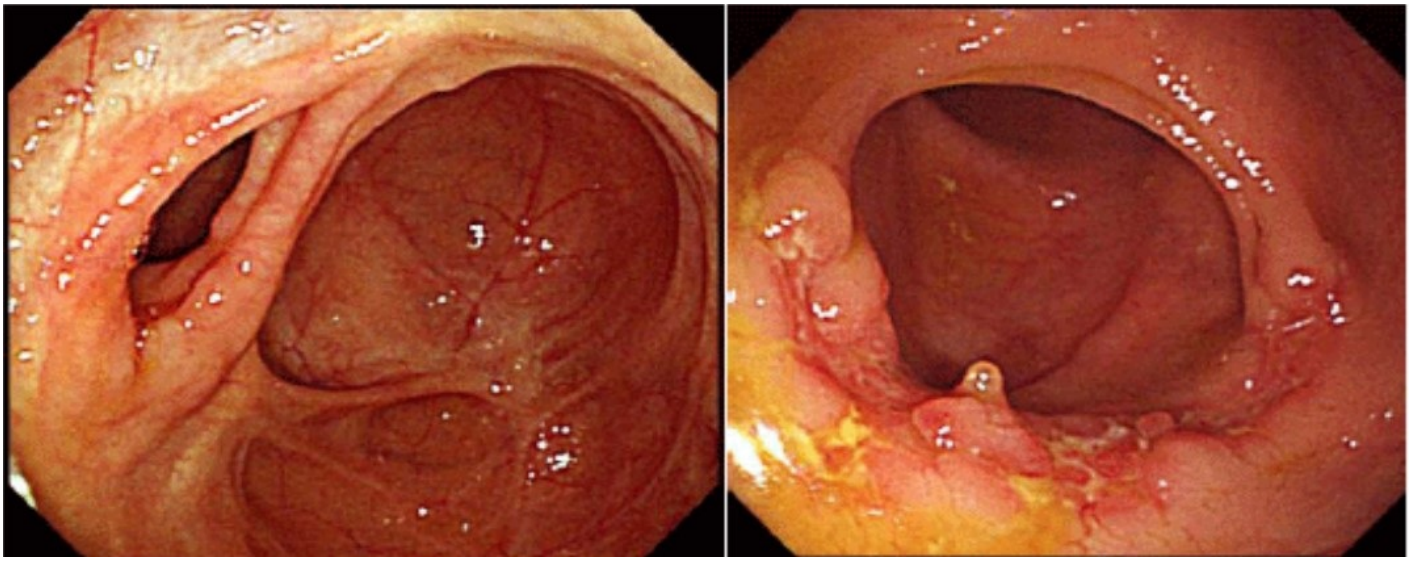
아스파르테이트아미노전달효소 22 U/L

알라닌아미노전달효소 33 U/L

혈액요소질소/크레아티닌 20/1.0 mg/dL

C-반응단백질 11 mg/L (참고치, <10)

T-SPOT.TB검사(+)



① 대장암

② 호산구성장염

③ 살모넬라장염

④ 궤양성대장염

⑤ 장결핵

정답 ⑤

결핵성 늑막염 병력이 있는 환자의 만성 설사, 미열, 인터페론감마분비검사(T-SPOT.TB) 양성, 대장내시경상 상행결장(회맹부)의 다발성 궤양은 장결핵을 가장 먼저 의심하게 한다. 장결핵의 궤양은 주로 회맹부에 생기며 장의 둘레 방향(횡축)으로 생기는 경향이 있다. 크론병과의 감별이 중요하다.

2020년

2020년 시험 60번

14. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Clostridium perfringens

② Giardia lamblia

③ Vibrio cholerae

④ Yersinia enterocolitica

⑤ Plesiomonas shigelloides

> **정답 ④**
>
> 원본에 지문이 빠져 있어 정확한 질문은 알 수 없다. 정답으로 표시된 Yersinia enterocolitica는 덜 익힌 돼지고기 · 오염된 우유로 감염되고 냉장 온도에서도 증식하며, 회장 말단 · 장간막 림프절을 침범해 충수염과 비슷한 우하복부 통증(가성충수염)을 일으키는 침습성 장염균이다. 반응성 관절염 · 결절성 홍반이 동반될 수 있고, 철 과부하(혈색소증, 데페록사민 투여)가 위험인자다.

2020년 시험 61번

15. 22세 남자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발압통은 없었으며, 최근 5 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 다음 시행할 가장 적절한 검사는?

CBC WBC 11600/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 654K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 5.1/2.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 55 mm/hr CRP 13.1 mg/dL

fecal calprotectin: 250 μg/g

① 대장내시경검사

② 복부컴퓨터단층촬영

③ 대변균배양검사

④ 복부자기공명영상

⑤ 호기수소검사

> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 1년 이상 지속되는 설사와 체중감소, 빈혈, 혈소판 증가, 저알부민혈증, ESR · CRP 상승, 대변 칼프로텍틴 상승은 기능성 질환이 아닌 장의 염증, 특히 염증성장질환(크론병 등)을 시사한다. 확진을 위해 회장말단까지 관찰하고 조직검사를 할 수 있는 대장내시경검사를 가장 먼저 시행한다. 호기수소검사는 유당불내성 · 소장세균과증식, 대변 배양은 급성 감염성 설사에서 의미가 크다.

16. 42세 여자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발 압통은 없었으며, 최근 2 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 혈액검사는 다음과 같다. 대장내시경 사진(1) 과 조직 검사 소견 (2)이다. 진단은?

CBC WBC 12500/㎕ (neutrophils 36%, lymphocytes 25%, eosinophils 34% and monocytes 5%)

Hb 11.9 g/dL Hct 38% Plt 254K/㎕

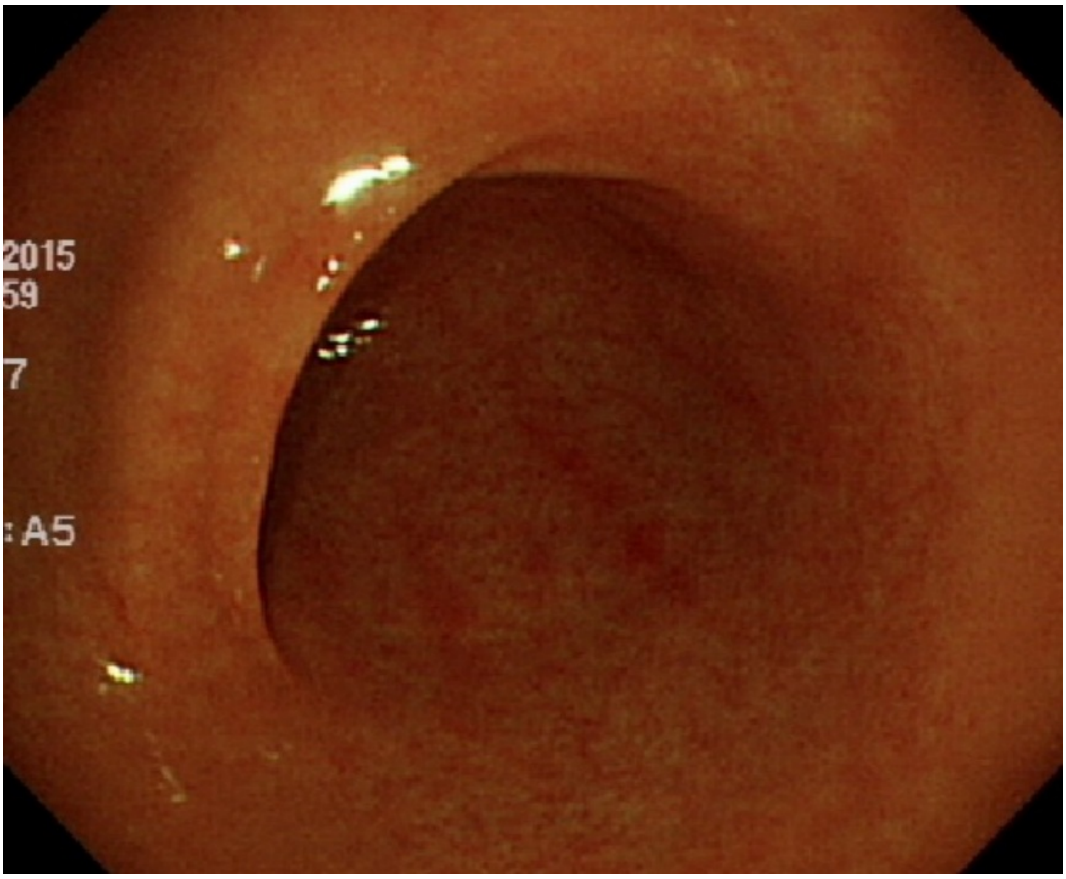
Chemical and electrolyte battery

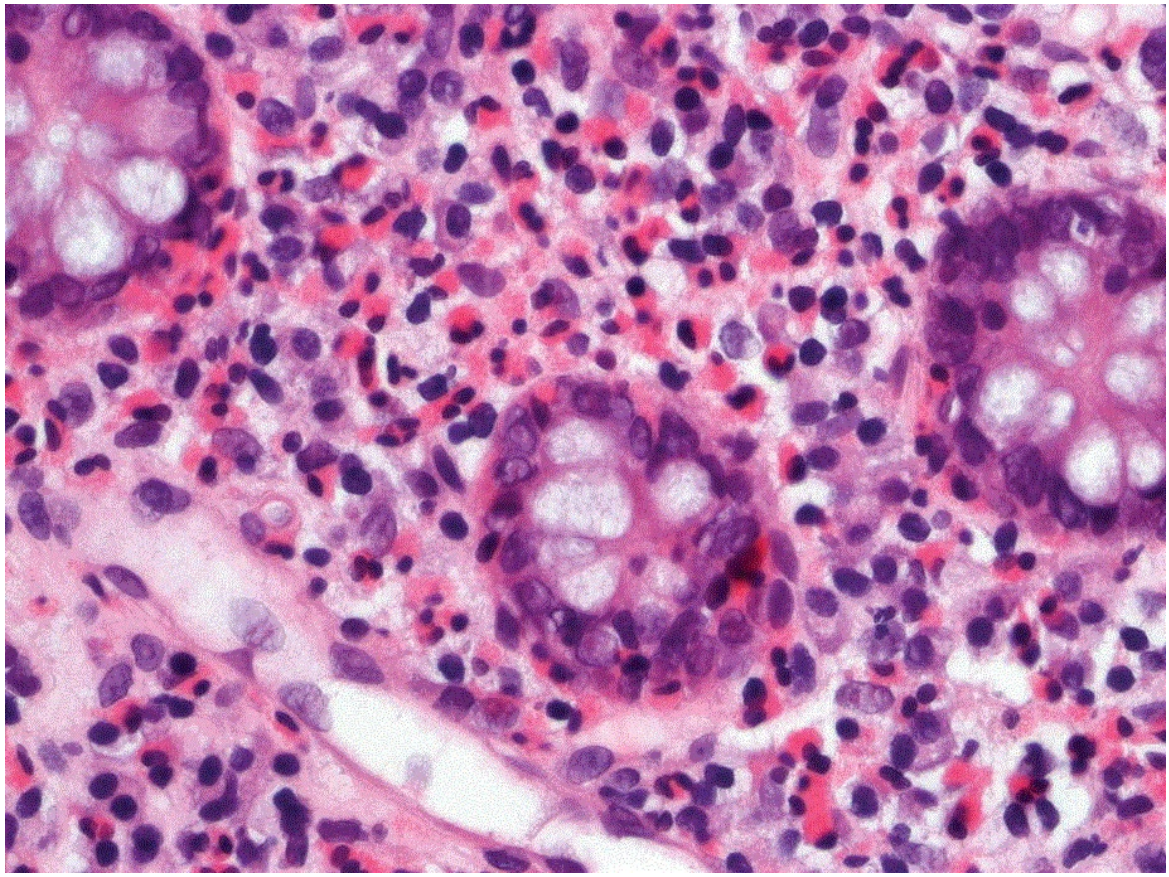
Protein/Alb 5.8/29 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 21mm/hr CRP 3.1 mg/dL





① 궤양성대장염
② 과민성대장염
③ **호산구성대장염**
④ 현미경적 장염
⑤ 소장세균과증식증

> **정답 ③**
>
> 만성 설사와 함께 말초혈액 호산구가 크게 증가(34%)하고, 대장 조직검사에서 점막에 호산구가 다수 침윤해 있으면 호산구성 대장염이다(기생충 감염 · 약물 등 이차 원인 배제 필요). 궤양성대장염은 혈변과 연속성 궤양, 현미경적 장염은 정상 내시경에 림프구 · 콜라겐 띠 침윤, 과민대장증후군은 정상 소견, 소장세균과증식은 호기수소검사로 진단한다(원본의 'Protein/Alb 5.8/29'는 원본 그대로 둠).